

オフライン運用に関する 想定問答集

Lu-177治療スケジューラ／メール端末上でのオフライン（通信なし）運用の検討にあたって

医療情報部（樋脇係長）や委員会から想定される質問と、その回答例をまとめました。回答例はたたき台です。院の実情に合わせて調整してご使用ください。

まず結論（推奨する運用モデル）

「親機1台方式」＋定期バックアップ＋患者ID中心の管理を推奨します。入力・保存はRI室の指定端末1台のみで行い、他メンバーには印刷した予定表で共有。同時編集による破損がなく、最もシンプルで安全です。共有の本格対応は、正式システム調達までの将来課題とします。

1 最重要：データ共有について

Q1 オフライン運用では、複数メンバーでどうやってデータを共有するのか？

A 完全な同時共有はオフライン単体では困難です。現実的には次の3案があり、**当面は案1を推奨**します。

案	やり方	長所	短所
案1 親機1台 方式 推奨	入力・保存は指定した 1台の端末のみ 。 他メンバーは 印刷した予定表 で共有	同時編集の破損なし。仕組み が単純で安全。すぐ始められる	入力は1台に集約（担当を決 める必要）
案2 データ受 け渡し	アプリからデータを 1つのファイル に書き 出し、許可された場所・媒体で受け渡し	複数端末で持ち回れる	置き場所・受け渡し手段に許 可が必要。版の管理に注意
案3 情報部 サーバ ー	情報部管理の正規サーバーで一元管理	本来の理想形。同時共有が可 能	体制・調達が必要（＝正式シ ステムの領域）

Q2 データはどこに保存される？端末を変えたら消えるのか？

A オフラインの場合、データはその端末(ブラウザ)内に保存され、別端末・別ブラウザとは共有されません。だからこそ「親機1台方式」が管理しやすくなります。消失に備え、定期的にデータを書き出しファイルとして保存します。

Q3 バックアップ・データ消失対策は？

A 親機端末で定期的にデータを書き出し、許可された保存場所に保管します。端末故障やブラウザ初期化に備えます。頻度(例:週1回、締切ごと)は運用規程で定めます。

2 セキュリティ・データ保護

Q4 患者情報が外部に漏れる心配はないか？

A インターネット・院内網に一切通信しません(完全オフライン)。保存データは暗号化します。保存場所は情報部のご指示に従います。さらに、患者氏名を持たず患者ID中心で運用することも可能で、その場合は個人情報の保有そのものを最小化できます。

Q5 マクロ(VBA)は使うのか？(Accessで問題になった点)

A 使いません。オフラインHTMLはブラウザの標準機能のみで動作し、マクロ実行を伴いません。Accessで懸念されたマクロ制限には該当しません。

Q6 HTMLファイルの改ざん・マルウェアのリスクは？

A ファイルの中身は情報部でレビュー(内容確認)可能です。動作はブラウザ内に限られ、外部通信は行いません。配置場所と変更管理(誰がいつ更新したか)を規程化し、正規のファイルのみを使用します。

3 可用性・保守・体制

Q7 誰が保守するのか？属人化しないか？

A 単一のHTMLファイルで構造が単純なため、ExcelやAccessよりむしろ保守は容易です(更新はファイル1つの差し替え)。ソース公開・手順書・責任者／副責任者の二名体制で属人化を排除します。

Q8 なぜメール端末なのか。他の端末ではダメか？

A 現場で使えてブラウザが利用できる端末として想定しています。どの端末を使うか（親機の指定を含む）は、情報部とご相談のうえ決定したいと考えています。

4 承認プロセス・位置づけ

Q9 独自ツールの業務利用は原則不可では？

A 承知しております。まずは技術的にリスクが最も小さい形（オフライン・通信なし・単一ファイル・マクロなし）を確定したうえで、医療情報管理運営委員会にお諮りいただくことを前提としています。正式システムが調達されるまでの暫定運用という位置づけです。

Q10 委員会には何を提出するのか？

A 改修要件定義書・セキュリティ設計書・本ツールのソースを提出します。責任体制（管理主体・責任者）と運用規程もあわせて整備します。

正直にお伝えすべき点（先に述べておくと信頼されます）

オフライン単体では「リアルタイムの多人数同時共有」はできません。この制約を隠さず、「当面は親機1台＋印刷共有で運用し、本格的な共有は正式システムで」と明確にすることが、委員会・情報部の理解を得る近道です。